EONU 이어온유

함께 오지 못해도,
이야기는 함께.

환자와 보호자의 일상을
의료진의 질문에 연결합니다.

AI 소통 솔루션 · IR 2026.10

환자 · 보호자 · 의료진의 일상 장면

환자는 왔지만,
이야기는 오지 못했습니다.

혼자 진료받는 아이와, 곁에 있지 못한 보호자.

한 아이의 진료 장면에서 시작한 질문 · 설명을 위해 재구성한 사례

01

혼자 진료받는 아이

02

곁에 있지 못한 보호자

03

짧은 시간 안에 확인하는 의료진

“언제부터 그랬나요?”

경험은 있지만,
변화를 설명하기 어렵습니다.

“알려드릴 게 있었는데.”

일상의 관찰을 아는 사람은
지금 곁에 없습니다.

“필요한 맥락이 더 있다면.”

이야기가 닿지 못한 자리에
정보의 공백이 남습니다.

세 사람의 이야기,
하나의 흐름으로.

환자의 경험 · 보호자의 관찰 · 의료진의 질문과 계획

PATIENT

환자

내 상황을 이해받고 싶어요.

GUARDIAN

보호자

관찰을 전하고,
진료 후 도울 일을 알고 싶어요.

서로 다른 필요를
하나의 소통 흐름으로

EONU

역할과 공유 범위에 맞게 정리

CLINICIAN

의료진

필요한 정보를 확인하고
질문과 계획을 전달합니다.

진료 후 관리계획 → 다시 일상으로

환자의 걱정이,
병원의 상담 기회로.

의료진이 계속 참여할 세 가지 이유. 먼저 수익 기여 가능성을 검증합니다.

가설 01
진료 효율
전체 확인 업무의 부담까지 함께 측정

가설 02
임상적 유용성
진료에 도움이 되는 맥락과 정보

먼저 검증할 가설
수익 기여 가능성
미해결 걱정이 자발적 상담으로 이어질까?

걱정이 닿는 곳에,
상담의 입구를 만듭니다.

일상에서
미해결 걱정
스스로 느끼는 걱정을
구체적으로 정리

→

병원 정보
관련 정보 탐색
병원이 설정한
서비스 정보 확인

→

당사자 선택
자발적인 상담
상담 요청과 지불 의사,
전체 업무 부담 검증

AI는 개별 치료나 비급여의 필요성을 판단하지 않습니다.

병원이 묻고,
일상에서 답합니다.

질문·서비스 정보·관리 안내를 먼저 설정합니다.

질문과 관리 안내를 설정하는 의료진

병원 설정 · 설명용 UI

다음 진료까지 확인할 것

질문
일상의 변화와 걱정

서비스 정보
병원이 제공하는 안내

관리계획
진료 후 실천할 내용

환자 · 보호자

QR

병원 안내로 시작

해당 병원과 연결된
질문과 안내를 확인합니다.

소통의 출발점은
의료진이 정한 기준입니다.

병원의 질문 → 가족의 관찰 → 다음 진료의 맥락

기록은 편하게.
전달은 확인하고.

병원 설정 → 일상 기록 → 공유 전 확인 → 의료진 확인

설명용 UI 도식 · 가상 데이터 · 실제 서비스 화면 및 EMR 연동 아님



첫 매출의 출발점은 병원 라이선스.

일차의료기관에서 유료 도입을 검증하고, 다음 고객으로 넓힙니다.

먼저 · B2B

병원 라이선스

일차의료기관에서 유료 도입 검증

가상 사례 검토
→ 범위·기간을 정한 제한 실증
→ 유료 제안과 계약

그다음 · B2B2C

추가 유료 가치

병원 도입 검증 이후
환자·보호자가 지불할
추가 가치를 확인합니다.

별도 경로 · B2G

공공 구매 검증

실제 구매기관과 예산이 있는
공공 계약 경로를 확인합니다.

연구지원금·민간 봉사활동과
구분합니다.

첫 병원군과 가격은 선정·검증 중 · 계약 체결을 의미하지 않습니다.

큰 시장에서,
먼저 살 고객을 좁힙니다.

현재 판매할 소프트웨어를 기준으로 TAM · SAM · SOM을 구분합니다.



포함 관계 개념도 · 면적은 금액·비율에 비례하지 않음

B2B

기관 수 × 연간 가격

B2B2C

연결 이용자 × 유료 전환율 × 연간 이용액

B2G

구매사업 수 × 계약 단가

입력값·가격은 산정 전
하드웨어·연구지원금·동일 계약 중복 합산 제외

범위와 산식 개념도 · 면적은 금액에 비례하지 않으며 시장 수치·가격은 산정 전

일상 기록에서,
연결된 건강 정보로.

병원 도입 검증 이후, 정보의 임상적 유용성과 입력 부담을 확인합니다.

병원 도입 검증 이후의 확장 방향 · 연동 및 임상 검증 완료를 뜻하지 않음

환자와 가족의 일상 기록

EONU

임상적 유용성 검토

후속 검토

병원 시스템 · EMR

권한과 연동 비용 확인

후속 검토

외부 건강 앱

환자·가족이 사용하는 정보 연결

추가 연구 과제

기기 · 디지털 바이오마커

ADHD·노년층의 접근성과 임상적 의미 검토

환자의 입력 부담과 반복 사용부터 확인

현장 피드백을,
첫 도입으로.

질문과 템플릿, 제품에 반영할 운영 경험을 모으고 있습니다.

현재 자료에 기재

전문의 피드백

정신과 전문의의 지속적 피드백

자문·협의 범위 확인 필요

현재 접점

연구기관 접점

도헌디지털의료혁신연구소

협의 상태와 범위 확인 필요

참여 확정 기재

청년 우울증 봉사

관련 자선사업 프로젝트 참여

공식 제휴·실증·계약과 구분

다음에는
도입의 증거로.

의료진 실제 활용 | 전체 업무 부담 | 반복 사용 | 구매 의사

질문 · 정보 템플릿 · 운영 경험으로 축적합니다.

1억 원,
첫 유료 모델을 향한 실행 자금.

의료·AI 이해를 바탕으로 직접 기획하고, 개발하고, 수정합니다.

창업자 프로필 사진

의료 · AI 이해를 바탕으로
직접 기획 → 개발 → 수정

1억 원

사용계획 총액

제품을 만들고, 현장에서 유료 가치를 검증합니다.

제품 개발	개인정보·보안	제한 실증	고객 확보	운영

필요한 협력 임상 확인 · 개인정보·보안 · 실증 운영

소개 · 직접 접촉 → 방문 데모 → 파일럿 → 유료 모델 검증

세부 배분·기간·기관 수·유료 고객 목표·CAC는 확정 전

사용계획 총액 · 세부 배분·기간·목표는 확정 전

EONU 이어온유

환자에게 필요한 연결.
병원도 계속 쓸 이유.



첫 병원군과 함께, 실제로 쓰이고 지불할 가치를 검증합니다.

환자 · 보호자 · 의료진, 이어지는 장면